

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. – fyzická osoba

(Statistické informace se poskytují podle zákona č. 89/1995 Sb., nikoliv podle zákona č. 106/1999 Sb.)

Jméno*: [redacted]

Příjmení*: [redacted]

Titul:

Datum narození*: [redacted]

Ulice a č.p.*: [redacted]

Obec*: [redacted]

PSČ*: [redacted]

Telefon:

E-mail*: [redacted]

Předmět žádosti*: Žádost o poskytnutí informací o matkách a novorozencích, kteří zemřeli při porodu.

Text žádosti*: Dobrý den,

jmenuji se [redacted]

[redacted] se zaměřuji na ochranu práv rodiček při porodu v České republice, konkrétně na to, jak jsou tato práva chráněna a jak se v praxi uplatňují.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

Informovaný souhlas

1. V jaké fázi péče je rodičkám běžně předkládán informovaný souhlas (např. při registraci, při příjmu, po začátku porodních bolestí)? Mají možnost se s tímto dokumentem seznámit i předem?
2. Jaký prostor mají rodičky k prostudování informovaného souhlasu a položení doplňujících otázek? Probíhá při tom vysvětlení významu jednotlivých zákroků (např. účel, rizika, alternativy)?
3. Umožňuje informovaný souhlas výběr konkrétních zákroků, se kterými rodička souhlasí nebo nesouhlasí, nebo se standardně podepisuje jako celek bez možnosti úprav?
4. Jak hodnotíte fungování informovaného souhlasu v praxi vaší nemocnice? Existují v této oblasti nějaké bariéry nebo aspekty, které by podle vás bylo možné zlepšit?

Dříve vyslovené přání

5. Setkáváte se v praxi s dokumenty označenými jako dříve vyslovené přání? Odpovídají tyto dokumenty zákonným náležitostem, nebo spíše formálně nevyhovují?

6. V jaké konkrétní situaci během porodu nemocnice přechází z režimu získávání aktuálního informovaného souhlasu rodičky na režim, kdy se vychází z dříve vysloveného přání?
7. Jak je ve vaší nemocnici dříve vyslovené přání vnímáno z hlediska jeho role v porodní péči? Existují podle vás praktické nebo právní překážky při jeho uplatnění?

Porodní plán

8. Pokud rodička předloží porodní plán, jak s ním nemocnice v praxi nakládá? Slouží spíše jako vodičko, informativní dokument, nebo se s ním dále nepracuje v průběhu porodu?
9. Jaký význam porodní plán ve vaší nemocnici fakticky má? Představuje podle vás vhodný nástroj komunikace mezi rodičkou a zdravotnickým personálem?

Zákroky bez souhlasu

10. V jakých konkrétních případech je podle praxe vaší nemocnice možné přistoupit k zákroku bez nebo proti informovanému souhlasu nebo dříve vysloveného přání (např. v zájmu zdraví dítěte nebo z jiných důvodů)?
11. Má nemocnice pro tyto situace zavedenou metodiku nebo doporučený postup, nebo závisí rozhodnutí vždy na ošetřujícím personálu?
12. Jak se zaznamenává do zdravotnické dokumentace, že k zákroku došlo bez souhlasu rodičky? A jak je to s rodičkou komunikováno?

Stížnosti a žaloby

13. Kolik stížností a kolik soudních žalob týkajících se porodní péče eviduje vaše zdravotnické zařízení?
14. Jaké důvody byly v těchto stížnostech a žalobách ze strany rodiček uváděny?
15. Kolik z těchto stížností a žalob bylo nemocnicí uznáno, kolik nikoli, a v kolika případech bylo poskytnuto odškodnění?
16. Jaký je počet stížností a žalob v oblasti porodní péče ve srovnání s jinými odděleními zdravotnického zařízení?

Postoj k mezinárodnímu hodnocení porodní péče

17. Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) ve svém hodnocení České republiky upozornil mimo jiné na zásahy prováděné bez předchozího informovaného souhlasu rodiček a na časté využívání epiziotomií bez jednoznačné medicínské indikace.
Budu velmi ráda, pokud se budete chtít k těmto závěrům vyjádřit a případně sdílet, jak jsou tato témata vnímána ve vaší praxi.

Prosím o zaslání odpovědí v elektronické podobě na e-mailovou adresu, ze které byla tato žádost odeslána.

Děkuji Vám za zvážení mé žádosti a za jakékoli informace, které budete schopni poskytnout.

S úctou,



Věc: poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sb- fyzická osoba – [REDAKCE]

informace pro potřeby [REDAKCE]

informovaný souhlas

1. rodičky se mohou seznámit s informovaným souhlasem při registraci, dále v rámci předporodních kurzů. Předem se s ním mohou seznámit také na našich webových stránkách. Pokud nemají předem vyplněný je samozřejmě předkládán při příjmu. Na vyplnění je necháván dostatek času.
2. prostor k doplňujícím dotazům mají dostatečný, význam zákroků a alternativy jsou vysvětlovány dle požadavků rodičky
3. výběr konkrétních zákroků informovaný souhlas neumožňuje, podepisuje jako celek, ale s možností úpravy. Na dané jednotlivé operační zákroky je podepisován samostatný informovaný souhlas
4. v praxi funguje informovaný souhlas dobře, zlepšení by mohlo být v oblasti webových stránek – možnost vyplnění předem na přímo na stránkách oddělení- je v plánu- zatím nefunguje

Dříve vyslovené přání

5. s dokumenty Dříve vyslovené přání se setkáváme- v málo procentech případů vyhovují zákonným náležitostem, ale většina jen formálně vyhovuje
6. většinou se nejprve vždy vychází z Dříve vysloveného přání a dle toho se upravuje informovaný souhlas
7. Dříve vyslovené přání je většinou vnímáno jako přání rodičky, které se snažíme dodržet. V případě sporných bodů vedeme s rodičkou rozhovor, ve kterém si sporné body vysvětlujeme a snažíme se najít kompromis. Někdy jsou požadavky na vedení porodu v Dříve vysloveném přání v rozporu s vedením porodu (např odmítání intermitentní monitorace plodu, odmítání zavedení kanyly, podání léků k zástavě krvácení apod)

Porodní plán

8. Porodní plán se snažíme dodržovat, stává se součástí dokumentace. Často se však sama rodička od porodního plánu odkloní.
9. porodní plán je jednou s možností komunikace s personálem. Vždy ale preferujeme procházet jednotlivé body porodního plánu s rodičkou ústně a případně podávat doplňující informace k jednotlivým bodům.

Zákroky bez souhlasu

10. k zákroku bez informovaného souhlasu přistupujeme pouze v akutním ohrožení života plodu nebo matky (hypoxie plodu, krvácení matky apod)
Vždy ale rodičku informujeme o nutnosti daného zákroku, zákrok vysvětlíme
11. Metodika zavedená není - jedná se o konkrétní akutní stavy a situace z nich vyplývajících
12. Indikace k zákroku, zdůvodnění provedení zákroku se zaznamená do dokumentace písemně indikujícím lékařem jeho jmenovkou a podpisem. Při odmítnutí zákroku musí být v dokumentaci zaznamenáno a podepsáno rodičkou, jejím doprovodem, lékařem a porodní asistentkou
Nutnost zákroku při jeho odmítnutí je opakovaně rodičce i doprovodu vysvětlena, vysvětleny důvody, průběh i rizika spojená s odmítnutím zákroku.

Stížnosti a žaloby

13. není definováno za jaké časové období je počet stížností a žalob myšleno. Během 30 -leté praxe si vybavuji jednu soudní žalobu - před cca 20 lety, a odhadem 5-6 stížností.
14. Důvodem bývá poškození plodu při porodu – např v důsledku hypoxie, stížnosti bývají na rozsah poranění při porodu v případě obtížného hojení, někdy i na protahovaný porod, který neprobíhal podle představ rodičky
15. Pokud si pamatuji - během mé 30 leté praxe byly nemocnicí uznány 2 stížnosti u kterých došlo k odškodnění. Jinak ke všem stížnostem se písemně personál nemocnice vyjadřuje. Je nabízena i možnost ústního vysvětlení. Žalobu neuznává nemocnice. Podnět k žalobě pokud je mi známo, dávají orgány trestního řízení - tedy PČR a státní zástupce. Žaloba, pokud vím, proběhla jedna před cca 20 lety s osvobozujícím výsledkem pro lékaře i porodní asistentku.
16. nevím jaký je počet stížností na jednotlivých odděleních – tudíž se k bodu nemohu adekvátně vyjádřit

Postoj k mezinárodnímu hodnocení porodní péče

17. K závěrům výboru OSN se nebudu vyjadřovat- myslím, že časté využívání episiotomií bez medicínské indikace je již minulostí. A pokud jsou provedeny zásahy bez předchozího informovaného souhlasu, jedná se většinou o zákroky vedoucí k záchraně života matky nebo plodu. Někdy jsou to stavy, kdy jde o minuty.
Je nutné si v kontextu uvědomit, že máme jedny z nejlepších perinatologických výsledků na světě, v ukazatelích mateřské a novorozenecké úmrtnosti patříme ke špičkám ve světě, máme jedny z nejnižších čísel.